

Uzależnienia *behawioralne*

Hazard, gry, pornografia, zakupy, jedzenie — mózg uzależnia się od czynności tak samo, jak od substancji. Mechanizm dopaminowy jest ten sam.

CZAS: 25 min czytanie + refleksja Psychoedukacja — bez skali

ŹRÓDŁO: Grant i wsp. (2010); Potenza (2014); DSM-5-TR; ICD-11

JAK UŻYWAĆ

Karta wprowadza pojęcie **uzależnień behawioralnych** (ang. *behavioral addictions*) — zaburzeń, w których obiektem uzależnienia jest *czynność*, nie substancja. Karta porządkuje: 1) jakie czynności mogą uzależniać, 2) **4 kryteria**, kiedy nawyk staje się uzależnieniem, 3) co je łączy z uzależnieniami substancjalnymi, 4) co odróżnia. Po przeczytaniu wykonaj *autorefleksję* dotyczącą Twoich powtarzających się zachowań.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ICD-11 (2022) i DSM-5-TR (2022) **uznają hazard patologiczny** oraz **zaburzenia używania gier** (ang. *gaming disorder*) jako uzależnienia behawioralne — z tymi samymi kryteriami diagnostycznymi co uzależnienia substancjalne. Badania neuroobrazowe (Potenza 2014) pokazują **tę samą dopaminergiczną aktywację** w prążkowiu w hazardzie patologicznym co w kokainie. Diagnostyka pozostałych (pornografia, zakupy, jedzenie kompulsywne, smartfon, praca, seks, sport) jest w trakcie standaryzacji — w praktyce klinicznej leczymy je tymi samymi metodami (CBT, MI, MBRP) z porównywalną skutecznością.

01 📖 Najczęstsze uzależnienia behawioralne

HAZARD PATOLOGICZNY

Zakłady, ruletka, automaty, kursy walutowe, krypto. *Uznane w DSM-5-TR i ICD-11*. Częstość: 0,5–2% populacji.

ZABURZENIA UŻYWANIA GIER

Komputer, konsola, gry mobilne, e-sport. *Uznane w ICD-11 (2019)*. Częstość: 1–3%, głównie młodzi mężczyźni.

PORNOGRAFIA / SEKS

Kompulsywne korzystanie z pornografii (CSBD). *ICD-11: zaburzenie kontroli impulsów*, badania trwają. Częstość: 3–6%.

ZAKUPY KOMPULSYWNE

Powtarzające się zakupy mimo strat finansowych. Częstość: 5–8% populacji.

SMARTFON / MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Kompulsywne sprawdzanie, mediów społecznościowych, przewijanie. *Badania w toku*. Częstość: 10–15% (młodzi).

JEDZENIE KOMPULSYWNE

Napady objadania (BED — DSM-5-TR), kompulsywne jedzenie. Częstość: 1–3% (BED), więcej u kobiet.

02 🕒 Cztery kryteria — kiedy nawyk to uzależnienie

Według DSM-5-TR i Griffithsa (2005) **komponenty uzależnienia behawioralnego** są te same co dla substancji. Cztery kluczowe:

1 · UTRATA KONTROLI

Próby ograniczenia bez powodzenia. Czas / pieniądze poza planem.

2 · TOLERANCJA

Potrzeba „więcej / dłużej / silniej”, żeby uzyskać ten sam efekt.

3 · ODSTAWIENIE

Drażliwość, napięcie, zły nastrój, gdy nie wykonujesz czynności.

4 · SZKODY

Praca, relacje, finanse, zdrowie cierpią — a czynność trwa.

03 Co je łączy / co odróżnia od uzależnień substancjalnych

WSPÓLNE

- Aktywacja układu nagrody (dopamina w prążkowiu)
- Osłabiona kora przedczołowa
- Cykl: głód → ulga → kompulsja
- Zaprzeczanie, racjonalizacja
- Wpływ stresu na nawroty
- Skuteczne metody: CBT, MI, MBRP, grupa wsparcia

RÓŻNE

- Brak chemicznych objawów odstawienia (drgawki, dreszcze)
- „Abstynencja” trudniejsza do zdefiniowania (telefon → nie da się go całkowicie unikać jak alkoholu)
- Stygmatyzacja często mniejsza („to tylko nawyk”)
- Diagnostyka mniej ustabilizowana
- Cel terapii: częściej *kontrolowane używanie* niż abstynencja

04 Autorefleksja

Pomyśl o czynności, do której wielokrotnie wracasz *mimo* kosztów. Odpowiedz uczciwie:

CZYNNOŚĆ, KTÓRA MNIE MARTWI

— konkretnie, bez ogólników

ILE Z 4 KRYTERIÓW (Z SEKCJI 02) ROZPOZNAJĘ U SIEBIE

— wymień

CO TA CZYNNOŚĆ MI DAJE

— jakiej emocji unikam, jaką szukam ulgi

Z KIM POROZMAWIAM O TYM

— terapeuta, lekarz, grupa

Klucz: Grant i wsp. (2010) w przeglądzie w *American Journal of Drug and Alcohol Abuse* pokazali, że uzależnienia behawioralne **aktywują te same obwody dopaminergiczne** co substancjalne — i odpowiadają na te same metody terapeutyczne (CBT, MI, leczenie farmakologiczne — np. naltrekson w hazardzie). Cel: nie wymagamy „silnej woli” — szukamy *specyficznego mechanizmu*, który u Ciebie utrzymuje cykl, i przerywamy go techniką dopasowaną do tego mechanizmu.